

TEMA 4.15 • DERMATOLOGÍA

Urticaria

PERFIL EUNACOM 6.01.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Urticaria (Síndrome Irritativo Eruptivo)

La Urticaria comprende un síndrome cutáneo de reacción de hipersensibilidad alérgica vasoactiva inmediata epidérmica comandado celularmente mediante la degranulación de los histaminocitos mediada fundamentalmente por inmunoglobulinas basales de **Anticuerpos IgE** libres locales provocando extremo edema vasomotor celular fugaz tisular agudo.

Factores Etiológicos Detonantes (Alergenos)

1. **Idiopática General Básica:** El detonante por excelencia, ocurre espontánea en la mayoría. 2. **Reacción Externa Específica Exógena:** Detonada como alergia cruzada fulminante por consumo base a mariscos (camarones), frutos secos de la cascara irritante o una reacción secundaria general Adversa a los consabidos y letales Fármacos / Medicamentos orales base irritantes. 3. **Vínculo Secundario Reactivo Indirecto:** Estímulo cruzado de alta relevancia clínica donde asoma el brote posterior generalizado habiendo cursado el paciente previamente días antes con leves **Infecciones y cuadros virales Respiratorios Altos reactivos.**

Cuadro Clínico Patognomónico Morfológico Temporal

- **Presentación Aguda Primaria de Lesión Específica:** El paciente debuta asustado en cosa de horas cruzado por la emergencia de **Ronchas (Pseudopápulas) y Habones gigantes.** - **La Semiología Diferenciadora:** Las ronchas urticarianas están provocadas estrictamente puras por edema local profundo y de paso temporal general. La regla de oro que las aísla a todas del abanico dermatológico cruzado subyace que **DESAPARECEN por completo su aspecto tras realizar simple compresión con los dedos / vitropresión**, blanqueándose fugazmente. - **La Signología Cardinal Torturosa Adicional Estigmática:** Manifiestan insoportable molestia general, **Alto y desesperante Prurito activo.** - **Evolución Diferencial Base por Cronología (Aguda VS Crónica):** - **Urticarias Agudas:** Exacerbaciones episódicas con duración intermitente cruzada fluctuantes transitorias puras de poquísimos días a semanas asintomáticas. - **Urticarias Crónicas Letales:** Evolucionada crónicamente superando la barrabasa de los largos 6 Meses ininterrumpidos de episodios reactivos enrojecidos fulminantes cruzados (asociados asediados al correr, tocar, o sudor cruzado). Frecuente al evaluar la placa reventar como manifestación de reactivación perenne en el examen clínico la maniobra cruzada y prueba física basal demostrando **Dermatografismo Cutáneo** (Escribir en la piel cruzado sano por fricción roma desata una reacción vascular ronchiforme local al pasar el romo afilado de placa o uña por sobre la epidermidis).

Escalera de Tratamiento Alergénico Reaccionario

- **Medida Principal N°1 Basal Primaria Terapéutica Ambulatoria generalizada de Oro:** Se centra férreamente la educación incondicionada para abolir contactantes descubiertos alergenicos y evitar irritantes básicos perimetrales de fricción o estrés cruzado. El pilar fundamental biológico reside transversal en frenar la degranulación general celular recetando **El pilar estricto de Antihistamínicos cruzados base Vía Oral puros de 2° (Segunda) Generación de base central panca no neurológica ni pasiva No Sedante "Anti H1"** (como los pilares orales libres generales basal central **Loratadina, Cetirizina o Fexofenadina oral crudas**). Jamás cruzar perimetral con los H2 de vía endodigestiva. - **Tratamiento Crítico Severo Excepcional (Anafilaxia / Angioedema letal general):** Si el brote general crudo no logra limitarse en la piel estallando hacia engrosamiento cruzado asfijante de vías y edema orofaríngeo glótico o hipotensión masiva, el nivel sube inmediatamente exigiendo de forma prioritaria uso cortando cruzados al corticoide base como **Adrenalina Intramuscular cruzada general (Epinefrina general aguda basal) sumada pasarela venosa Cruz Corticoides Sistémicos en emergencia.**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es la característica que diferencia la roncha de otras lesiones sobre elevadas?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Urticaria. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La urticaria produce ronchas que desaparecen a la presión y se resuelven en menos de veinticuatro horas.
- La causa más frecuente de urticaria crónica es idiopática, no alérgica.
- Urticaria aguda dura menos de seis semanas y crónica más de seis semanas.
- El dermatografismo es una urticaria mecánica donde las lesiones aparecen al trazar líneas en la piel.
- Los antihistamínicos H1 de segunda generación no sedantes son el tratamiento de primera línea.
- Con angioedema asociado se agregan corticoides al tratamiento antihistamínico.
- La anafilaxia con compromiso sistémico requiere adrenalina intramuscular de urgencia.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (URTICARIA)

PREGUNTA 1

¿Cuál es la característica que diferencia la roncha de otras lesiones sobreelevadas?

- A)** La roncha tiene contenido seroso y se rompe espontáneamente en veinticuatro horas
- B)** La roncha desaparece completamente a la presión y se resuelve sola sin dejar marca
- C)** La roncha tiene base eritematosa fija que no cambia con la compresión digital
- D)** La roncha produce descamación intensa en las cuarenta y ocho horas posteriores
- E)** La roncha deja hiperpigmentación residual permanente al resolver el episodio

PREGUNTA 2

¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la urticaria sin angioedema?

- A)** Corticoides orales como prednisona en ciclo corto de cinco días
- B)** Antihistamínicos H1 de primera generación sedantes como la difenhidramina
- C)** Antihistamínicos H1 de segunda generación no sedantes como loratadina o cetirizina
- D)** Adrenalina subcutánea para revertir la liberación de histamina mediada por IgE
- E)** Inmunosupresores como ciclosporina desde el primer episodio de urticaria

PREGUNTA 3

¿Cuánto tiempo debe durar la urticaria para clasificarse como crónica?

- A)** Más de dos semanas de forma continua o intermitente
- B)** Más de tres meses con episodios al menos semanales
- C)** Más de seis semanas con episodios frecuentes de ronchas
- D)** Más de un año de evolución con diagnóstico confirmado
- E)** Más de cuatro semanas según la clasificación internacional actualizada

RESUMEN: URTICARIA

La urticaria es una enfermedad muy frecuente caracterizada por la aparición de ronchas o habones que son lesiones eritematosas sobreelevadas de bordes bien definidos que desaparecen completamente a la presión digital y se resuelven espontáneamente en menos de veinticuatro horas sin dejar marca. La causa más frecuente es idiopática, seguida de las reacciones alérgicas mediadas por IgE. Puede ser aguda cuando dura menos de seis semanas, o crónica cuando dura más de seis semanas. La urticaria puede asociarse a angioedema, que es el edema de la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, afectando labios, párpados y lengua. El dermatografismo es una forma especial de urticaria mecánica donde las lesiones se producen al trazar líneas sobre la piel. El tratamiento de primera línea son los antihistamínicos H1 de segunda generación no sedantes como la loratadina, cetirizina y fexofenadina. Cuando se asocia angioedema se agregan corticoides. En caso de anafilaxia con compromiso sistémico el tratamiento es la adrenalina intramuscular.